

Пиелопластика

Информация для пациента · Операция по устранению сужения в месте отведения мочи из почки

WARWIKI

Пиелопластика — операция, устраняющая сужение в месте соединения почки с мочеточником (трубкой, по которой моча поступает в мочевой пузырь). Сужение задерживает мочу и вызывает боль, инфекции или перегрузку почки. Хирург удаляет суженный участок и создаёт широкое, свободно дренирующее соединение — наиболее надёжный метод с успехом более 90%.

Об этой операции

В верхней части мочеточника, там, где он соединяется с лоханкой почки (**почечной лоханкой**), может развиваться сужение, замедляющее отток мочи. Иногда его вызывает давление ближайшего **кровеносного сосуда**. Это состояние называется **обструкция UPJ** (лоханочно-мочеточникового сегмента). При пиелопластике хирург:

- Удаляет суженный участок
- Пришивает здоровый мочеточник к почечной лоханке, формируя **широкое воронкообразное соединение**
- Оставляет мягкий внутренний **стент**, чтобы держать соединение открытым во время заживления

Как правило, операция выполняется **роботически или лапароскопически** через несколько небольших разрезов; реже — через один открытый разрез.

Это безопасно?

Пиелопластика — хорошо изученная и высокоэффективная операция с долгосрочным успехом более 90%. Как любое хирургическое вмешательство, она несёт определённые риски: кровотечение, инфекция или временное подтекание мочи (обычно контролируется стентом и дренажем). Рецидив сужения нечаст и, как правило, поддаётся повторному лечению.

ТЕРМИНЫ

Почка

Орган, фильтрующий кровь и вырабатывающий мочу.

Мочеточник

Трубка, по которой моча идёт из почки в мочевой пузырь.

UPJ

Лоханочно-мочеточниковый сегмент — место соединения почки с мочеточником; место сужения.

Почечная лоханка

Воронкообразный резервуар, где скапливается моча перед поступлением в мочеточник.

Мочеточниковый стент

Мягкая внутренняя трубка («двойной J»), удерживающая место герметичным при заживлении.

Перекрещивающийся сосуд

Кровеносный сосуд, который может давить на сегмент UPJ и вызывать обструкцию.

Гидронефроз

Расширение почки из-за застоя мочи выше места сужения.

Робот / лапароскопия

Малоинвазивная операция через несколько небольших разрезов.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей анестезией — вы ничего не чувствуете. После неё возможна болезненность в области небольших разрезов, а также дискомфорт в плече или животе из-за газа, используемого при лапароскопии. Стент может вызывать учащённые позывы или лёгкую боль в боку при мочеиспускании. Большинство пациентов остаются в стационаре 1–2 ночи; операция обычно занимает 2–3 часа.

Как подготовиться (до операции)

- Операция под **общей анестезией** — соблюдайте все инструкции: голодание и отмена препаратов (в том числе антикоагулянтов).
- **Анализ мочи** исключает инфекцию — при её наличии сначала проводится лечение.
- Запланируйте **ношение стента около 4–6 недель** и организуйте сопровождение домой.

Сообщите команде заранее, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете текущую инфекцию мочевых путей
- Перенесли операции на почке или органах брюшной полости

Что происходит во время операции

- 1 Вам вводят анестезию и антибиотики.
- 2 Хирург делает несколько небольших разрезов (или один открытый) и получает доступ к суженному сегменту.
- 3 Суженный участок удаляется, почечная лоханка моделируется заново.
- 4 Здоровый мочеточник пришивается к лоханке широкой воронкой поверх стента; при необходимости оставляется дренаж, разрезы ушиваются.

После операции

- Обычно вас выписывают через **один-два дня**.
- **Стент остаётся около 4–6 недель**, затем удаляется в ходе короткой офисной цистоскопии.
- Симптомы стента (позывы, лёгкая боль в боку, розоватая моча) — **норма**. **Избегайте нагрузок** несколько недель; пейте достаточно жидкости.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Сильная или нарастающая боль в боку или животе
- Обильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Отсутствие мочеиспускания, стойкая тошнота или рвота
- Нарастающее покраснение, боль или выделения в области разреза

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Пиелопластика устраняет обструкцию UPJ и создаёт широкое соединение — наиболее надёжный метод, обычно выполняемый через небольшие разрезы.
2. Подготовка: соблюдайте режим голодания и инструкции по препаратам, сначала вылечите инфекцию, рассчитайте на стент 4–6 недель и организуйте сопровождение.
3. Стент может вызывать позывы или боль в боку до его удаления — это нормально.